

Inflammation et Infection : Importance de l'anamnèse et du status

La fièvre en tant que telle est **très peu spécifique**, elle se place souvent au centre du système immunitaire, de la génétique et de l'environnement.

1. Fièvre

La fièvre se définit comme une **T° > 38°** (2x à minimum à 30 minutes d'intervalle) ou **> 38.5°** (1x). Il faut savoir si la fièvre est accompagnée ou non de frissons :

- **petits frissons** : état grippal qui passent avec une couverture
- **frissons solennels** : le lit tremble, les frissons ne sont pas maîtrisables, souvent **d'origine bactérienne**

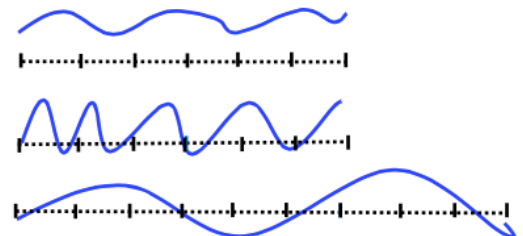
1.1. Prise de la température

Centrale : tympanique ou rectale

Périphérique : axillaire, mais très peu souvent prise, car elle sous-estime la 'vraie' température (= la température centrale) de ~ 0,5°C

La fièvre peut se présenter de différentes manières, qu'il est indispensable de décrire lorsqu'on la caractérise :

- **continue** : les patients ne descendent pas en dessous de 38°, souvent les personnes immunosupprimées
- **intermittente** : souvent les maladies infectieuses, avec une présentation en fièvre tierce ou quarte (= tous les 3 ou 4 jours)
- **ondulante** : plutôt pour des pathologies tumorales (= fièvres qui évoluent au cours de la journée)



1.2. Causes de la fièvre

Les deux **principales** causes de fièvre sont d'origine **infectieuse (50% !!) et inflammatoire**. Il existe aussi les fièvres **médicamenteuses** (antibiotiques), oncologiques, transfusions sanguines, thromboses veineuses ou encore factices.

2. Le malade fébrile ; à quoi penser lorsqu'on mène l'anamnèse

Il est important de faire une bonne anamnèse en récoltant le maximum d'informations, puis un bon examen clinique en observant attentivement le patient.

a. Facteurs prédisposant à l'infection

❖ Facteurs qui diminuent les défenses

La présence **d'infections récidivantes** doit nous faire penser à une **diminution des défenses**, qui peuvent être une anomalie anatomique ou fonctionnelle :

- **brèches dans les barrières naturelles** (lésion de peau ou des muqueuses = plaies chroniques)
- **obstructions** (voies urinaires ou digestives)
- **corps étrangers** (cathéter, sonde, prothèses)
- **médicaments**
- **matériel prosthétique** (prothèse de hanche)
- **valvulopathie cardiaque** (insuffisance aortique)
- **immunosuppression** (primaire, chimiothérapie, radiothérapie, médicaments (corticostéroïdes), transplantations d'organes, **infection au VIH**, splénectomie)
- **maladies chroniques** (métabolique (diabète), cardiaque, pulmonaire (BPCO), hépatique, rénale, cancer, maladies inflammatoires, toxicomanie, alcoolisme et malnutrition)

Illustrations

1. Homme de 47 ans avec antécédents de colites néphrétiques et infections urinaires récidivantes, douleurs au flanc gauche : **abcès rénal** sur un calcul préalable
2. Homme de 32 ans, toxicomanie intraveineuse, fatigue, malaise et frissons, souffle cardiaque : **embol septique** (part depuis le cœur en direction de la périphérie), il peut y avoir une endocardite comme complication
3. Femme de 65 sous chimiothérapie, neutropénie, douleur et rougeur au niveau de l'épaule gauche : **infection de la voie centrale** (signe d'alerte important car ses défenses sont nulles !)
4. Patiente de 33 ans, souffrant d'un lymphome, sous chimio, lésions cutanées de type vésiculaire : **zona** (réactivation de la varicelle)

On notera qu'il est possible de différencier une douleur infectieuse d'une douleur due par exemple à des calculs rénaux par le fait qu'une douleur **infectieuse** est une douleur qui est **constante**, alors qu'une douleur **colique** est au contraire une douleur qui fonctionne par pics espacés de périodes sans douleur.

❖ Exposition à l'environnement

Les expositions à l'environnement sont multiples et pas forcément exotiques : un éternuement dans le métro, poser ses mains sur un bureau. Toute une série de facteurs peuvent nous infecter : malades, personnel soignant, eau, air, nourriture ou encore les animaux.

Les principaux vecteurs environnementaux comptent surtout les **mains**, les **objets** et les **aérosols**.

❖ Voyages et Origines

Pour caractériser un état fébrile après un retour de voyage, il est utile de connaître les éléments suivants :

Exposition

- continent, pays, région et altitude
- Saison, température et durée du voyage

Mesures préventives

- prophylaxie
- vaccination

Suivant les indices donnés par le patient, on suspectera principalement :

- gastroentérite virale/bactérienne (= cause **la plus fréquente**)
- malaria
- fièvre de Dengue
- fièvre typhoïde

- fièvre hémorragique

Illustrations

1. Femme de 54 ans, grosse fièvre, frissons et sudations importantes après un retour du Vietnam sans vaccination ni prophylaxie : **malaria**
2. Femme de 27 ans déshydratée qui souffre de crampes abdominales, vomissements et diarrhées après un voyage en Afrique : **gastroentérite à salmonella typhi**
3. Homme de 43 originaire de l'Angola, en Suisse depuis trois mois, dyspnée, toux avec hémoptysies : **tuberculose**

b. Vaccinations

On va cibler plusieurs groupes de population :

- enfants (chez eux, la couverture est en règle générale très bonne grâce au suivi pédiatrique)
- voyageurs (suivant les vaccins pris avant le voyage)
- immunosupprimés (VIH ou transplantation => vaccins à faire AVANT !)
- personnes âgées (moins bien vaccinées et relativement immunosupprimées)

c. Maladies inflammatoires

Les maladies inflammatoires constituent la 2^e cause de fièvre après les maladies infectieuses. On retient les **vasculites**, le lupus érythémateux systémique (l'une des formes de **connectivites**) (LES), la **polyarthrite rhumatoïde** ou encore la sarcoïdose.

3. Symptômes généraux (B)

Pendant l'anamnèse, on demande au patient s'il a ressenti les éléments suivants :

- Des frissons
- Une perte de poids
- Des malaises, une fatigue
- Des sudations (diurnes et/ou nocturnes)

Lors de l'examen clinique, il est important de **mesurer sa température et ses signes vitaux** (fréquence cardiaque, artérielle et TA). On observe son état général, notamment son hydratation et sa nutrition. On peut ensuite procéder à l'anamnèse par système (haut en bas ou du plus concerné au moins concerné).

En conclusion, face à une fièvre il faut d'abord **déterminer quelle est son origine** (infectieuse ou inflammatoire dans la majorité des cas, sans oublier les autres) en procédant de manière systématique, car on trouve ce que l'on cherche !